

Nome: JOSEMAR SOUZA RODRIGUES
Data de Nascimento: 28-4-1973
IMC: 29,07
Sexo: Masculino
Data do exame: 06-09-2024

Peso: 84 kg
Altura: 1,70 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 06-09-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 490,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 17,5 e 110,5 minutos. O tempo total de sono foi de 394,5 min, eficiência de 80,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,6%; estágio N2: 62,2%; estágio N3: 17,2%; sono REM: 18,9%. O índice de despertares foi de 16,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 36,3/hora, sendo 33 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 187 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 81%, permanecendo 4,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 60 - 103 bpm e NREM de 62 - 99 bpm.

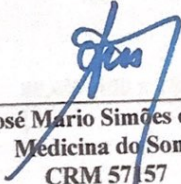
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 36,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=81%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: JOSEMAR SOUZA RODRIGUES

Sexo: Masculino

Data do Exame: 28-02-2025

Idade: 51 anos

Peso: 84 kg

Altura: 1,70 m

Médico Solicitante: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 28/02/2025 21:44 e finalizado às 01/03/2025 05:37.

A latência para início do sono foi de **16,0** min e a latência para o sono REM de **87,0** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 390,0 min, com eficiência do sono de **82,4** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **2,4** % de estágio N1, **55,6** % de estágio N2, **20,6** % de estágio N3 e **21,3** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 67,5 min. Ocorreram 75 despertares, sendo o índice de **9,5 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 50, sendo 1 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 49 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **7,7 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 11,6 e o IDR durante o sono NREM foi de 6,6. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 7,7 (nº/h), sendo 0,2 apneia/h e 7,5 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 94%, a média de 93% e a mínima de 88%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 6,2 (nº/h), sendo que em REM foi de 11,6 (nº/h) e em NREM foi de 6,4 (nº/h). Permaneceu 0,1 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Saturação da oxi-hemoglobina normal (94%);
2. Latência para o início do sono normal (16,0 min) (VN= 5 a 30 min);
3. Latência para o início do sono REM normal (87,0 min) (VN= 70 a 120 min);
4. Eficiência do sono diminuída (82,4 %) (VN= $\geq 85\%$);
5. Índice de despertares normal (9,5 n^o/h) (VN= até 15 n^o/h);
6. Percentual do estágio N1 normal (2,4 %) (VN= 2% a 5%);
7. Ligeiro aumento do percentual do estágio N2 (55,6 %) (VN= 45% a 55%);
8. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (20,6 %) (VN= 13% a 23%);
9. Percentual do estágio REM normal (21,3 %) (VN= 20% a 25%);
10. Ronco leve, intermitente, verificado via sensor de ronco;
11. presença de atividade em EMG de queixo;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

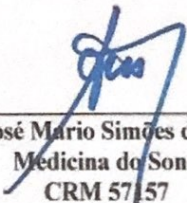
Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

INDICADO POR: Ademir Candido
() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

JOSEMAR SOUZA RODRIGUES

IDADE: 52 PESO: 84 ALTURA: 1,40 PROFISSÃO: Agente Sanitário Ambiental
SINTOMAS: Cansaço diurno (Sobrepeso)

QUEIXAS: Falta disposição
MEDICAMENTOS: Bravonidol / Levoide

MÉDICO: Dr. Mario Sérgio

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza atividade

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5h ALMOÇO: 5h LANCHE: - JANTAR: 19h

HORA QUE DORME: 22:30h HORA QUE ACORDA: 5h

COCHILHO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: (X) S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N 2 (cachorro)

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 1X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 36,34h SPO2: 88% (06/09/24)

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS / Tireoide

CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N SPO2 CI/CPAP: 88% PRESSÃO NO EXAME: 8cmH2O

24/09/25 Avaliação

07/10/25 Início adaptação Compresor BMC
Auto 4-10 Press. Pico
Natasha